

F

分類不能型間質性肺炎
unclassifiable interstitial pneumonia

到達目標

- ◆ 特発性間質性肺炎における分類不能型特発性間質性肺炎の位置づけを説明できる
- ◆ 分類不能型間質性肺炎の疫学を説明できる
- ◆ 分類不能型間質性肺炎の治療と予後を説明できる

病因・病態・疫学

a 疾患概念

2002 年 ATS/ERS の特発性間質性肺炎の国際集学的合意分類では、本文中の注釈に分類不能型間質性肺炎 (unclassifiable interstitial pneumonia) が初めて記載された¹⁾。ただし、臨床的には有用ではない診断名と判断され、新たな疾患分類として認められなかった。

2013 年に発表された ATS/ERS の特発性間質性肺炎の改定国際合意分類では、主要特発性間質性肺炎と希少特発性間質性肺炎に加え分類不能型特発性間質性肺炎 (unclassifiable idiopathic interstitial pneumonias) が初めて特発性間質性肺炎の新たな疾患分類として明記された²⁾。分類不能型特発性間質性肺炎は以下の場合である。

- 1 臨床、画像、あるいは病理データが不足または不適切である場合
- 2 以下の理由で臨床、画像、病理の間で大きな不一致がある場合
 - i 治療の影響 (例：ステロイド治療が開始された後の DIP は、画像上 NSIP 様となる)
 - ii 現在の ATS/ERS の分類では特徴づけられない新しい分類、現行にある分類の亜型あるいは現在の分類では十分に分類できない場合 (例、線維化を伴った器質化肺炎など)
 - iii HRCT および/あるいは病理パターンで複数のパターンがある場合

(病理パターンで複数のパターンが存在する分類不能な症例では、特発性間質性肺炎ではなく、膠原病肺や薬剤性肺障害がその症例に関連していることがしばしば証明されている)

b 疫学

研究デザインや臨床状況によって診断割合が変化するが、間質性肺疾患のうち 10% から 25% で分類不能型間質性肺炎と診断されることが多い (表 1)。Ryerson らが行った単施設の後向き研究では、2000 年 1 月から 2011 年 4 月までに間質性肺疾患と診断された 1370 人のうち分類不能型間質性肺疾患は、9.6% (132 人) であった³⁾。分類不能型間質性肺炎と診断された最も一般的な理由は、外科的肺生検のリスクが高いために病理組織学的評価ができなかったこと (52%) であった。次いで、臨床画像病理像の解離 (18%)、軽症または病状が安定しており生検の利点が少ないと判断された症例 (9%)、診断するには肺生検の組織が小さすぎる症例 (8%) であった。

症候・身体所見

分類不能型特発性間質性肺炎は、多様な疾患の集合であり、個々の症例により症候や身体所見は変化する。

診断・検査

疾患分類、重症度判定のために胸部 HRCT、呼吸機能検査、間質性肺炎マーカー、肺生検などの検査が必要である (図 1, 図 2)。Ryerson らの報告では、診断時の分類不能型間質性肺炎の年齢、%FVC、%DLco は、IPF や IPF 以外の特発性間質性肺炎との差は認めなかった。また、2011 年 IPF ガイドラインに基づく HRCT 分類では、UIP パターン 17%、possible UIP パターン 50%、inconsistent with UIP パターン 33% と報告している³⁾。

治療と予後

a 治療

薬物治療の選択は、分類不能型特発性間質性肺炎を対象とした直接的な研究がない。また多様な疾患を含んでおり、症例毎に考慮する必要がある。一般的には、最も可能性の高い診断に基づき治療すべきである。また、IPF の可能性が高い患者と非 IPF 線維性間

表 1 コホート研究による分類不能型間質性肺炎の患者背景

国名	年	分類不能型間質性肺炎の割合 (n)	外科的肺生検の割合
スペイン	1995-2004	14.6% (73/500)	26.2%
中国	1999-2009	15.1% (38/251)	100%
スペイン	2000-2001	5.1% (26/511)	22.7%
アメリカ	2000-2011	9.6% (132/1370)	31%
デンマーク	2003-2009	24% (105/431)	28%

(Skolnik K, et al : Respirology 21 : 52, 2016 より作成)